신OO님 보장분석 · 제안 보고서

고객 정보

성명 / 연령 / 성별	신OO / 만 36세 / 여
분석 기준일	2026-08-13
보고서 작성일	2026-08-14
자료 출처	한국신용정보원 집적 계약정보 기반 보장분석 (2026-08-13 13:37:40 조회)
담당	OOO

한눈에 보는 요약

보유 계약	**3건 (전부 현대해상, 정상계약)**
월 납입 보험료	**119,550원**
총 납입 보험료 (현 보험료 기준)	**29,050,800원**
기납입 보험료	**16,118,610원**
앞으로 낼 보험료(잔여)	**12,932,190원**
납입 진행률	**55.5%**

보장 준비상태 집계 (권장금액 설정 담보 기준)

구분	충분	부족	미가입	판정대상 합계	
담보 수	**10**	**10**	**20**	**40**	

핵심 진단 (요약)

① 지켜야 할 것	2010년 가입 실손은 2세대(표준화 이전기)로 자기부담 10%·재가입 조건 없이 100세(2090년)까지 유지됩니다. 현행 5세대 대비 비급여 보장이 넓어 보유 계약 중 가치가 가장 높습니다. → 시트 '6.실손분석' 참고
② 가장 큰 공백	생존 담보가 비어 있습니다. 일반암 1,000만원(권장 1억 대비 -9,000만), 뇌·심장 진단비 전 항목 미가입, 간병·치매 전 항목 미가입.
★ 2026 3대 트렌드	항암약물·방사선 치료를 받을 때마다 반복 지급(표적항암제 연 6,000만~1억 2,000만원 대응) → 미보유. ② 순환계 주요치료비 — 검사·수술·혈전용해·ECMO·재활까지 전 과정 포괄, 부정맥·심부전까지 확대 → 미보유(진단비조차 0원). ③ 정액 수술보험금 — 5세대 실손의 비중증 비급여 축소(자기부담 30%→50%, 한도 5,000만→1,000만)로 역할이 커진 담보 → '16대질병수술 100만원'
③ 사망보장 편중	상해사망 1억 6,000만원은 있으나 질병사망은 0원입니다. 36세 여성 기준 사망원인의 대부분이 질병이라는 점과 어긋납니다.
④ 운전자보험	2017년 가입분이라 변호사선임비용의 자기부담금 50%(2026년 개정) 적용을 받지 않는 유리한 약관이지만, 교통사고처리지원금 3,000만원(권장 2억)·변호사선임비용 500만원은 현 시세 대비 크게 부족합니다.
⑤ 만기 주의	치아보험(계약③)은 2034-10-01, 만 44세 만기입니다. 이후 치과보장과 보철치료비 200만원이 함께 소멸합니다. 자동차보험(KB다이렉트)은 2026-08-19 만기로 갱신 시점이 임박했습니다.

※ 본 보고서는 고객 요청에 따라 '현황 정리' 중심으로 작성되었습니다. 신규 가입 제안 및 예상 보험료는 포함하지 않았습니다.
※ 권장금액은 KB손해보험 보장분석 기준(기본형 37개 담보 / 표준형)을 따랐습니다.
※ 시트 '4.담보마스터'의 담보명·권장금액·코멘트를 수정하면 '3.보장분석(메인)'에 자동 반영됩니다.

계약별 현황 및 보험료 (총 / 기납입 / 잔여)

총납입·기납입·잔여 보험료는 '월보험료 × 회차'로 산출한 수식값입니다. 기준일(N3)을 바꾸면 전 시트가 자동 재계산됩니다.

기준일 → 2026-08-13

계약	회사 / 상품명	계약일	만기일	납입 주기	납입기간	만기연령	월 보험료	총 납입보험료	기납입 보험료	잔여 보험료	납입 진행률	갱신 여부 / 특이사항
① Hi1010 (종합)	현대해상 무배당하이라이프퍼펙트패키지보험(Hi1010)2종	2010-12-23	2090-12-23	월납	25년납 (~2035-12-23)	100세 만기	56,300원	16,890,000원	10,584,400원	6,305,600원	62.7%	비갱신(만기까지 확정) 주력 종합보험. 2세대 실손 포함, 100세 만기
② Hi1709 (운전자)	현대해상 무배당하이카운전자보험(Hi1709)2종기본플랜	2017-11-20	2070-11-20	월납	20년납 (~2037-11-20)	80세 만기	12,930원	3,103,200원	1,357,650원	1,745,550원	43.8%	비갱신 운전자 전용. 2026년 개정 前 약관(변호사비 자기부담금 없음)
③ Hi1904 (치아)	현대해상 무배당퍼펙트치아보험(갱신형)(Hi1904) 기본플랜	2019-10-01	2034-10-01	월납	15년납 (~2034-10-01)	44세 만기	50,320원	9,057,600원	4,176,560원	4,881,040원	46.1%	갱신형(보험료 인상 가능) 전기납 갱신형. 2034.10 만기 후 치과보장 소멸
	(계약 추가 시 이 행에 입력)											
합 계							119,550원	29,050,800원	16,118,610원	12,932,190원	55.5%	

산출 기준	월보험료 × 납입 회차. 기납입 회차 = MIN(총 납입회차, 계약일부터 기준일까지 경과 개월수 + 1회).
계약③ 주의	치아보험은 갱신형이므로 갱신 시 보험료가 오릅니다. 위 총납입·잔여 보험료는 '현재 보험료가 만기까지 유지된다'는 가정의 최소 추정치입니다. 실제 총액은 이보다 커집니다.
계약③ 만기	2034-10-01(만 44세) 만기 = 납입만기와 동일한 전기납 구조입니다. 만기 후 치과보장은 소멸합니다.
자동차보험	KB다이렉트개인용(2025-08-19~2026-08-19)은 신용정보원 조회분으로 위 3건과 별개입니다. 시트 '9.특이사항' 참고.

신OO님 담보별 보장분석 (보장분석24 포맷 기준)

담보명·권장금액은 트랜드·코랜드 '4.담보마스터'에서, 계약별 가입금액은 '5.담보원장'에서 자동으로 가져옵니다. 금액 단위: 만원(일당은 만원/일).

	↓ 계약번호(수식 참조용)	1	2	3								
	대분류	담보명	단위	① Hi1010 (종합)	② Hi1709 (운전자)	③ Hi1904 (치아)	합계 (가입금액)	권장금액 (KB기준)	과부족	준비 상태	2026 시장통용 설계수준	트랜드기준 과부족	최근 담보유형 (2026년 트랜드) 비교	특이사항 / 코멘트
	사망	**일반(종신)사망**	만원	-	-	-	-	10,000	-10,000	**미가입**			종신사망 자체는 정제. 사망보험금 유동화(연금·요양비 전환) 제도 도입으로 활용도 재조명	미가입. 손보 종합보험에는 통상 미탑재 — 필요 시 생보 종신/정기로 보완 영역
	사망	**질병(정기)사망**	만원	-	-	-	-	10,000	-10,000	**미가입**	10,000	-10,000	80세·90세 만기 정기형 질병사망이 주류. 종신형 대비 보험료 1/3 수준	미가입 (권장 1억 대비 -1억). 한제 사망보장은 '상해' 에만 존재
	사망	**재해(정기)사망**	만원	-	-	-	-			—			생보 재해사망 개념. 손보는 '상해사망'으로 대체 표기	손보 계약이므로 상해사망 행으로 집계
	사망	**상해(정기)사망**	만원	16,000	-	-	16,000	20,000	-4,000	**부족**	20,000	-4,000	상해사망 + 교통상해사망 + 대중교통이용중 상해사망으로 세분화 설계	계약이 기본계약 1,000만 + 상해사망후유장해추가 1억 5,000만 = 1억 6,000만 (권장 2억 대비 -4,000만)
	수술·입원	**수술비-질병(1~5종)**	만원	-	-	-	-	50	-50	**미가입**	1,000	-1,000	★★★2026 3대 핵심 트렌드 ①. 5세대 실손(2026.5.6~)의 비중증 비급여 축소로 정액 수술비의 역할이 커졌습니다. 비중증 비급여 자기부담 30% → 50%, 연간 한도 5,000만 → 1,000만, 통원 1회 20만·병의원 입원 1회 300만 제한 신설. 정액 수술비는 급여·비급여를 따지지 않고 수술확인서만으로 정액 지급되며 반복 청구가 가능해 이 공백을 메웁니다. 1~5종 종수술비(5종 기준 500~1,000만원)가 표준이며, DB손보 '반값 종수술비' 등 판매 경쟁 진행 중	계약이 16대질병수술 100만원. 2010년 약관 기준이라 질병군별 범위가 좁고, '16대에 해당하는지'를 매번 따져야 하는 한정형 구조입니다
	수술·입원	**수술비-NC대질병**	만원	100	-	-	100	100	-	**충분**	500	-400	NC대 범위 확대(16대 → 38대·61대·105대). 다만 최근에는 질병군을 한정하지 않는 1~5종 종수술비 + 질병통합치료비 조합으로 주계중심이 이동	★미가입 — 최우선 검토 대상. 계약⊙은 '16대질병수술 100만원' 한정형인 것이, 16대에 들어가지 않는 수술은 정액 보험금이 0만입니다. 예: 비중증 수술비 300만원 발생 시 5세대 실손 기준 본인부담이 90만원 → 150만원으로 늘어나는데, 신OO님은 2세대 실손이라 실손 쪽 받어는 유리하나 '실손이 아예 안 되는 항목·조과분'은 정액 수술비로만 메울 수 있습니다
	수술·입원	**수술비-재해(상해)**	만원	-	-	-	-	100	-100	**미가입**	1,000	-1,000	상해 1~5종 종수술비 + 부위별 특정상해수술 병행 설계가 표준. 정액형이라 급여·비급여 구분 없이 지급되며, 5세대 실손 축소의 대안 담보로 함께 거론됨	미가입. 계약⊙는 관절·인대·척추 등 부위별 특정상해수술만 보유해 해당 부위가 아닌 상해수술은 정액 보험금이 0원입니다
	수술·입원	**질병통합치료비(검사·시술·수술 포괄)**	만원	-	-	-	-			—	1,000	-1,000	★2026 신설 트렌드 담보. 검사 → 시술 → 수술 → 중증치료를 하나로 묶어 정액 지급하는 확장형 담보. 5세대 실손의 통원·외래 부담 증가에 대응하는 대안으로 수술비와 함께 급부상. 메리츠·KB손보·하나손보 등 판매	미가입. 수술 단계만 보는 수술비보다 앞단(검사·시술)까지 포괄해 실손 축소분을 넓게 메우는 구조
	수술·입원	**입원일당-질병**	만원/일	2	-	-	2	3	-1	**부족**	5	-3	상급종합병원 가산형·중환자실 가산형 확산. 기본 3만 + 상급종합 추가 3만 구조	계약⊙ 2만 (권장 3만 대비 -1만)
	수술·입원	**입원일당-NC대질병**	만원/일	2	-	-	2	3	-1	**부족**			4대상인병 → 15대·31대 성인질환으로 대상 확대	계약⊙ 4대상인병 1만 + 5대만성질병 1만 = 2만
	수술·입원	**입원일당-재해(상해)**	만원/일	2	-	-	2	3	-1	**부족**	5	-3	상해입원일당은 1일차부터 지급이 표준화	계약⊙ 2만 (권장 3만 대비 -1만). 계약⊙ 교통상해입원일당 1만 별도
	수술·입원	**통원일당**	만원/일	-	-	-	-			—			실손과 중복되어 최근 축소 추세	미가입
	암	**CI(중대질병)진단자금**	만원	-	-	-	-			—			CI형은 지급요건이 엄격해 축소. GI형·일반진단비형이 주류	미가입
	암	**중대한 수술비**	만원	-	-	-	-			—			CI 계열 담보. 신규 판매 축소	미가입
	암	**암사망**	만원	-	-	-	-			—			암사망 단독 특약은 희소	미가입
	암	**일반암 진단비**	만원	1,000	-	-	1,000	10,000	-9,000	**부족**	10,000	-9,000	★진단금 일시금 → '치료 전 과정 보장'으로 이동. 치료예약 확정 시 선지급(초기 50% → 현재 70%)	★계약⊙ 1,000만 (권장 1억 대비 -9,000만) — 전체 담보 중 최대 공백. 2010년 가입분으로 재진단형·고액암 없음
	암	**암수술비**	만원	100	-	-	100	300	-200	**부족**	500	-400	로봇수술·중입자치료 등 고액 비급여 수술을 별도 담보로 분리	계약⊙ 100만 (권장 300만 대비 -200만)
	암	**암입원일당**	만원/일	5	-	-	5			—			상급종합병원 암입원일당 가산형	계약⊙ 5만
	암	**암통원**	만원/회	-	-	-	-			—			항암치료의 통원 전환으로 통원일당 수요 증가	미가입
	암	**고액암(특정암)**	만원	-	-	-	-	5,000	-5,000	**미가입**	5,000	-5,000	고액암 범위 확대(백혈병·뇌암·골수암·췌장암 등)	미가입 (-5,000만)
	암	**유사암(소액암)**	만원	-	-	-	-	2,000	-2,000	**미가입**	2,000	-2,000	유사암 한도 상향(1,000만 → 2,000만 이상). 여성 갑상선암 발생 비중이 높아 실효성 큼	미가입 (-2,000만). 36세 여성 기준 발생빈도 1순위 영역
	암	**표적항암약물허가치료비**	만원	-	-	-	-	3,000	-3,000	**미가입**	5,000	-5,000	표적·면역항암 치료비를 별도 담보화, 연간 반복지급형(1년 1회 한)	미가입 (-3,000만). 타그리소 4주 600만원 등 고액 비급여 대응 불가
	암	**항암방사선·약물치료비**	만원	-	-	-	-			—	1,000	-1,000	회차별 증가형(치료 반복 시 지급액 증액) 신설 — 종국화재 5대질병 통합치료지원비 최대 1,000만	미가입
	암	**양성자/호르몬/세기조절**	만원	-	-	-	-			—	3,000	-3,000	중입자·양성자 치료비 별도 담보화	미가입
	암	**암주요치료비(비급여 포함)**	만원	-	-	-	-			—	3,000	-3,000	★★★2026 3대 핵심 트렌드 ①. 2024년 2월 삼성화재를 시작으로 전 손보사 확산. '진단 시 한 번'이 아니라 수술·항암약물치료·항암방사선치료 등 실제 치료행위를 반복 대비다 반복 지급. 표적항암제(연 6,000만~1억 2,000만원), 중입자치료(1크스 5,000만~8,000만원), 로봇수술 등 고액 비급여를 직접 보전. 치료예약 확정 시 선지급(초기 50% → 현재 70%). DB손보 최대 1억 2,000만원 / 비급여 암치료비 최대 8,000만원. 현재는 정액형만 판매 (2024년 11월 비례형 중단). 시장 통용 설계 3,000만원 내외	★미가입 — 최우선 검토 대상. 계약⊙의 암 담보는 진단 1,000만·수술·100만·입원일당 5만이 전부로, '치료 단계'를 보전하는 담보가 하나도 없습니다. 실손(2세대이) 급여 치료비는 막아주지만 표적항암제·중입자치료 같은 비급여 고액치료는 실손 한도로 감당되지 않습니다. 기업 시 병원등급 기준(종합병원 / 암종합치료기관 / 상급종합병원 중 어디까지 인정하는지)을 반드시 확인해야 합니다
	특정질환	**특정질병수술**	만원	-	-	-	-			—			16대 → NC대 확대. 아래 '수술비-NC대질병' 행으로 집계	계약⊙ 16대질병수술 100만은 '수술비-NC대질병' 행에 집계(중복 방지)
	특정질환	**특정질병입원**	만원/일	-	-	-	-			—			성인질환 입원일당은 '입원일당-NC대질병' 행으로 집계	계약⊙ 2만은 '입원일당-NC대질병' 행에 집계(중복 방지)
	특정질환	**특정질병진단**	만원	-	-	-	-			—			생활질환(고혈압·당뇨·고지혈) 통합보장으로 진화 — 흥국화재 7종 세분화, 롯데손보 고당지 3·6·10	미가입
	특정질환	**뇌혈관질환 수술비**	만원	-	-	-	-	1,000	-1,000	**미가입**	1,000	-1,000	수술비 → 주요치료비 → 순환계 통합치료비로 3단계 진화	미가입 (-1,000만)
	특정질환	**허혈성심장질환 수술비**	만원	-	-	-	-	1,000	-1,000	**미가입**	1,000	-1,000	스텐트삽입술·관상동맥우회술 고액화(관상동맥우회술 건당 3,440만원)	미가입 (-1,000만)
	특정질환	**혈전용해제(혈전용해치료비)**	만원	-	-	-	-			—			단독 담보에서 통합치료비로 흡수되는 추세	미가입
	특정질환	**뇌·심 주요치료비 / 순환계 통합치료비**	만원	-	-	-	-			—	2,000	-2,000,	★★★2026 3대 핵심 트렌드 ①. 진단비 → 주요치료비 → 순환계 통합치료비의 3단계 진화. ① 대상 확대: 뇌혈관·허혈성심장 2대 질병 → 부정맥·심부전·판막질환 등 순환계 전반(라이나생명 62개 질병코드) ② 지급 사유 확대: MRI·PET-CT 검사, 수술 전, 혈전용해치료·혈전제거술, 인공호흡기·ECMO, 중환자실 치료, 항응고/항혈소판 주사, 전문재활치료까지 치료 전 과정 ③ 치료 항목별 차등 지급 + 상급종합병원 예약만으로 일부 선지급 ④ 치료기간 소득공백 보전용 생활비 지원 결합. 시장 통용 설계 2,000만원 내외	★미가입 — 최우선 검토 대상. 신OO님은 뇌·심장 담보가 진단비 단계조차 0원이라, 최신 통합치료비 구조와는 비교 자체가 성립하지 않는 상태입니다. 60대 사망원인 2위 심장질환(33,715명)·3위 뇌혈관질환(25,420명), 관상동맥우회술 건당 3,440만원·뇌기저부수술 2,035만원을 감안하면 진단비 + 통합치료비를 함께 보는 것이 현재 시장 표준입니다
	특정질환	**5대장기이식술**	만원	-	-	-	-			—			조혈모세포이식 2,000~3,000만 등 이식 관련 담보 확대	미가입
	뇌	**뇌혈관질환(100%)**	만원	-	-	-	-	3,000	-3,000	**미가입**	3,000	-3,000	진단비(기본) + 통합치료비 결합 설계가 표준. 산정특례 진단비 병행	미가입 (-3,000만)
	뇌	**뇌혈관 산정특례**	만원	-	-	-	-			—			산정특례 등록 시 별도 진단비 지급 담보 신설 확산	미가입
	뇌	**뇌졸중(77%)**	만원	-	-	-	-	3,000	-3,000	**미가입**	3,000	-3,000	뇌출혈 500~2,000만 / 뇌경색 200~1,000만. 뇌경색 감액 약관 주의	미가입 (-3,000만)
	뇌	**뇌출혈(16%)**	만원	-	-	-	-	3,000	-3,000	**미가입**			후유장해 50% 이상 시 추가 1,000~2,000만 지급형 확산	미가입 (-3,000만)
	심장	**심혈관질환(100%)**	만원	-	-	-	-			—	3,000	-3,000	허혈성 대비 보장범위가 넓은 심혈관질환 진단비로 상향 설계	미가입
	심장	**심장 산정특례**	만원	-	-	-	-			—			산정특례 진단비 병행 설계	미가입
	심장	**허혈성심장질환(85%)**	만원	-	-	-	-	3,000	-3,000	**미가입**	3,000	-3,000	60대 사망원인 2위(심장질환 33,715명). 진단비 + 통합치료비 결합	미가입 (-3,000만)
	심장	**급성심근경색증(8%)**	만원	-	-	-	-	3,000	-3,000	**미가입**			급심 단독보다 허혈성/심혈관 상위담보 우선 설계 권장	미가입 (-3,000만)
	기타	**골절진단비**	만원	30	50	-	80	100	-20	**부족**			치아파절 포함형으로 확대, 깁스치료비·부목 별도 담보화	계약⊙ 30만 + 계약⊙ 50만 = 80만 (권장 100만 대비 -20만)
	기타	**화상진단비**	만원	50	-	-	50			—			중증(심재성 2도 이상)화상 2,000만 별도 담보	계약⊙ 50만
	기타	**골절·화상 수술비**	만원	160	-	-	160			—			인공관절수술 100만, 깁스 10만 등 세분화	계약⊙ 골절수술 60만 + 화상수술 100만
	기타	**특정상해수술(부위별 합계)**	만원	-	560	-	560			—			부위별 특정상해수술은 운전자·상해보험의 표준 구성	계약⊙ 관절2/치·내장100/무릎인대30/아킬레스50/인면골절선형200/이상성치추50/안공골절100 — 부위별 담보로 1사고 합산지급 아님
	기타	**특정부위(팔·손가락) 상해후유장해**	만원	1,000	-	-	1,000			—			부위 한정 후유장해 담보	계약⊙ 1,000만. 부위 한정이므로 일반 상해후유장해와 별도 집계
	기타	**중환자실·응급실 일당**	만원/일	-	-	-	-			—			중환자실 15~20만/일(30~60일), 상급병실 10~15만/일 트렌드	미가입
	기타	**기타 질환(양성뇌종양·특정전염병 등)**	만원	-	-	-	-			—			만성질환 통합보장 및 유병자 인수기준 완화(입원·수술 확인기간 5년 → 2년)	미가입
	기타	**근골격계 비급여 정액담보(도수·체외충격파·증식)**	만원	-	-	-	-			—			5세대에서 3대 비급여(도수·비급여주사·MRI) 보장 제외 방안이 주도되면서 별도 정액담보로 분리 판매되는 추세	'별도 특약 없음. 다만 신OO님의 2세대 실손은 3대 비급여가 기본 보장에 포함(자기부담 10%)되어 한제로서는 이 담보의 필요성이 낮습니다 — 2세대를 유지할 이유가 하나 더 있는 셈
	기타	**비급여 주사제 담보**	만원	-	-	-	-			—			5세대 비중증 비급여 자기부담 50% 연 1,000만 한도 적용 대상. 별도 정액담보 분리 판매 확산	별도 특약 없음. 2세대 실손 기본 보장에 포함(자기부담 10%)
	간병	**간병인사용일당(상해)**	만원/일	-	-	-	-	25	-25	**미가입**	10	-10	간병인 실제비용 10~15만원/일 → 7~10만원/일 이상 설정 권장. 간병도우미료 물가 전년비 13% 상승	미가입 (-25만)
	간병	**간병인사용일당(질병)**	만원/일	-	-	-	-	25	-25	**미가입**	10	-10	간호·간병통합서비스 병행형 상품 확산	미가입 (-25만)
	간병	**장기요양(1~5등급) 간병비**	만원	-	-	-	-	3,000	-3,000	**미가입**	3,000	-3,000	등급별 차등지급, 5등급·인지지원등급까지 보장 확대	미가입 (-3,000만)
	간병	**경증치매(CDR1) 진단비**	만원	-	-	-	-	10,000	-10,000	**미가입**	1,000	-1,000	CDR1 500~1,000만 / CDR2 1,000~2,000만 / CDR3 2,000~3,000만. 신경인지기능 종합검사비 지원, 아밀로이드 베타 표적치료제 회차별 치료비 신설(하나손보)	미가입 (-1억). 일부 약관은 CDR2부터 지급하므로 CDR1 보장 여부 확인 필요
	후유장해	**질병후유장해(80%미만)**	만원	-	-	-	-	10,000	-10,000	**미가입**			질병 3% 이상 후유장해 비례보상형 확대	미가입 (-1억)
	후유장해	**상해후유장해(80%미만)**	만원	16,000	-	-	16,000	10,000	6,000	**충분**			상해 3% 이상 비례보상이 표준	계약⊙ 1,000만 + 1억 5,000만 = 1억 6,000만 (권장 1억 대비 +6,000만) — 충분
	후유장해	**고도장해**	만원	-	-	-	-			—			80% 이상 고도장해는 사망보험금과 동일 지급이 일반적	미가입
	후유장해	**장해연금**	만원/년	-	-	-	-			—			연금형 장해보장은 생보 중심	미가입
	실손	**질병입원의료비**	만원	5,000	-	-	5,000	5,000	-	**충분**			5세대(2026.5.6~): 급여 연 5,000만 / 중증비급여 연 5,000만 / 비중증비급여 연 1,000만. 급여 입원 자기부담 20%, 비중증 비급여 입원 자기부담 50%. 축소된 비중증 영역은 정액 수술비·질병통합치료비로 보완하는 것이 2026년 시장 표준	★계약⊙ 2세대(표준화 이전기) 5,000만 — 자기부담 10%, 재가입 조건 없이 100세(2090년)까지 유지. 5세대 대비 압도적으로 유리하므로 유지가치 매우 높음
	실손	**질병통원의료비**	만원	30	-	-	30	30	-	**충분**			5세대는 통원 1회당 20만원 한도, 급여 통원은 건강보험 본인부담률과 연동(상급종합 이용 시 부담 증가)	계약⊙ 외래의료비 25만 + 처방조제료 5만 = 30만
	실손	**상해입원의료비**	만원	5,000	-	-	5,000	5,000	-	**충분**			5세대 병의원 입원 1회당 300만원 제한 신설	계약⊙ 상해+질병 입원의료비 5,000만 (질병입원과 동일 담보)
	실손	**상해통원의료비**	만원	30	-	-	30	30	-	**충분**			통원 자기부담 방식이 정액공제 → 본인부담률 연동으로 전환	계약⊙ 외래의료비 25만 + 처방조제료 5만 = 30만
	실손	**3대비급여(도수·주사·MRI)**	만원	-	-	-	-	350	-350	**미가입**			3세대부터 특약 분리(자기부담 30%), 5세대는 비중증 비급여로 분류되어 자기부담 50%·연 1,000만 한도	'별도 특약 없음. 단 2세대는 3대비급여가 기본 보장에 포함(자기부담 10%)되어 실질 보장은 오히려 우위 — '미가입'으로 보이나 실질 공백 아님
	운전자	**벌금(대인/스쿨존/대물)**	만원	-	2,000	-	2,000	3,000	-1,000	**부족**	3,000	-1,000	대인 3,000만(어린이보호구역 포함) 대물 500만이 최신 표준. 위험운전치상 벌금 700~1,500만 가능	계약⊙ 2,000만 (권장 3,000만 대비 -1,000만). 2017년 약관으로 대물벌금 미탑재
	운전자	**교통사고처리지원금**	만원	-	3,000	-	3,000	20,000	-17,000	**부족**	20,000	-17,000	★2억~2.5억 권장. 2025년 개정으로 어린이집·유치원·초등학교 시설 내 어린이 사고가 12대 중과실에 추가	★계약⊙ 3,000만 (권장 2억 대비 -1억 7,000만) — 운전자보험 최저 공백
	운전자	**변호사선임비용**	만원	-	500	-	500	5,000	-4,500	**부족**	1,500	-1,000	★2025년 개정: 심급별 최대 500만·총 1,500만 + 자기부담금 50% 신설(신규 가입분)	계약⊙ 500만. 2017년 약관이라 자기부담금 없는 유리한 조건이나 절대 한도가 부족
	운전자	**자동차사고부상치료비**	만원	10	20	-	30	30	-	**충분**			부상등급 1~14급 차등, 14급(단순 타박)도 약 30만원 지급형 확산	계약⊙ 10만(비운전자) + 계약⊙ 20만(운전자) = 30만 — 충분
	운전자	**중증자동차사고부상**	만원	-	1,000	-	1,000			—			중상해(1~3급) 고액 보장 담보 확대	계약⊙ 1,000만
	운전자	**교통상해입원일당**	만원/일	-	1	-	1			—			자동차 운전 중 상해 입원 1~180일 한정형	계약⊙ 1만
	운전자	**과실치사상 벌금**	만원	-	700	-	700			—			일반 과실치사상 벌금 담보	계약⊙ 700만
	운전자	**보철치료비**	만원	-	5	200	205	200	5	**충분**			자동차사고 치아보철(영구치) 보장. 치아보험과 별개	계약⊙ 5만 + 계약⊙ 200만 = 205만 — 충분. 단 계약⊙은 2034.10 만기 후 소멸(→ 5만만 잔존)
	배상	**가족/일상/자녀 배상책임**	만원	10,000	-	-	10,000	10,000	-	**충분**			1억 한도 표준, 자기부담금 2만원. 자전거·반려동물 사고 포함	계약⊙ 1억 — 충분
	배상	**화재벌금**	만원	-	2,000	-	2,000	2,000	-	**충분**			실화·중과실 화재 벌금 2,000만 표준	계약⊙ 2,000만 — 충분
	치아	**치아보존치료(충전·인레이 등)**	만원	-	-	40	40			—			갱신형 치아보험은 통상 만기가 짧고 면책·감액기간(90일/50%) 존재	계약⊙ 40만. 2034-10-01(44세) 만기 후 보장 종료
	치아	**기타 치과치료비**	만원	-	-	18	18			—			치주치료·스케일링·발치 등 소액 다빈도 보장	계약⊙ 주요치주질환 3만 / 영구치발치 10만 / 스케일링 1만 / 치수치료 3만 / 치아할영 1만 (건별 지급)
	(추가)	**여기부터 담보를 추가하세요**	만원	-	-	-	-			—				
	Err:508	**Err:508**	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	**Err:508**	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508

담보마스터 (구분 · 담보명 · 권장금액 · 최신 트렌드 · 코멘트)

★ 이 시트가 '3.보장분석(메인)'의 원본입니다. 여기서 담보를 추가·수정·삭제하면 메인 시트에 그대로 반영됩니다.

No	대분류	담보명(표준)	단위	권장금액 (KB기준, 만원)	2026 시장통용 설계수준(만원)	최근 담보유형 (2026년 트렌드)	특이사항 / 코멘트
1	사망	**일반(종신)사망**	만원	10,000		종신사망 자체는 정체. 사망보험금 유동화(연금·요양비 전환) 제도 도입으로 활용도 재조명	미가입. 손보 종합보험에는 통상 미탑재 — 필요 시 생보 종신/정기로 보완 영역
2	사망	**질병(정기)사망**	만원	10,000	10,000	80세·90세 만기 정기형 질병사망이 주류. 종신형 대비 보험료 1/3 수준	미가입 (권장 1억 대비 -1억). 현재 사망보장은 '상해'에만 존재
3	사망	**재해(정기)사망**	만원			생보 재해사망 개념. 손보는 '상해사망'으로 대체 표기	손보 계약이므로 상해사망 행으로 집계
4	사망	**상해(정기)사망**	만원	20,000	20,000	상해사망 + 교통상해사망 + 대중교통이용중 상해사망으로 세분화 설계	계약① 기본계약 1,000만 + 상해사망후유장해추가 1억 5,000만 = 1억 6,000만 (권장 2억 대비 -4,000만)
5	수술·입원	**수술비-질병(1~5종)**	만원	50	1,000	★★★2026 3대 핵심 트렌드 ③. 5세대 실손(2026.5.6~)의 비중증 비급여 축소로 정액 수술비의 역할이 커졌습니다. 비중증 비급여 자기부담 30% → 50%, 연간 한도 5,000만 → 1,000만, 통원 1회 20만·병의원 입원 1회 300만 제한 신설. 정액 수술비는 급여·비급여를 따지지 않고 수술확인서만으로 정액 지급되며 반복 청구가 가능해 이 공백을 메웁니다. 1~5종 종수술비(5종 기준 500~1,000만원)가 표준이며, DB손보 '반값 종수술비' 등 판매 경쟁 진행 중	★미가입 — 최우선 검토 대상. 계약①은 '16대질병수술 100만원' 한정형만 있어, 16대에 들어가지 않는 수술은 정액 보험금이 0원입니다. 예: 비중증 수술비 300만원 발생 시 5세대 실손 기준 본인부담이 90만원 → 150만원으로 늘어나는데, 신OO님은 2세대 실손이라 실손 쪽 방어는 유리하나 '실손이 아예 안 되는 항목·초과분'은 정액 수술비로만 메울 수 있습니다
6	수술·입원	**수술비-N대질병**	만원	100	500	N대 범위 확대(16대 → 38대·61대·105대). 다만 최근에는 질병군을 한정하지 않는 1~5종 종수술비 + 질병통합치료비 조합으로 무게중심이 이동	계약① 16대질병수술 100만원. 2010년 약관 기준이라 질병군 범위가 좁고, '16대에 해당하는지'를 매번 따져야 하는 한정형 구조입니다
7	수술·입원	**수술비-재해(상해)**	만원	100	1,000	상해 1~5종 종수술비 + 부위별 특정상해수술 병행 설계가 표준. 정액형이라 급여·비급여 구분 없이 지급되며, 5세대 실손 축소의 대안 담보로 함께 거론됨	미가입. 계약②는 관절·인대·척추 등 부위별 특정상해수술만 보유해 해당 부위가 아닌 상해수술은 정액 보험금이 0원입니다
8	수술·입원	**질병통합치료비(검사·시술·수술 포괄)**	만원		1,000	★2026 신설 트렌드 담보. 검사 → 시술 → 수술 → 중증치료를 하나로 묶어 정액 지급하는 확장형 담보. 5세대 실손의 통원·외래 부담 증가에 대응하는 대안으로 수술비와 함께 급부상. 메리츠·KB손보·하나손보 등 판매	미가입. 수술 단계만 보는 수술비보다 앞단(검사·시술)까지 포괄해 실손 축소분을 넓게 메우는 구조
9	수술·입원	**입원일당-질병**	만원/일	3	5	상급종합병원 가산형·중환자실 가산형 확산. 기본 3만 + 상급종합 추가 3만 구조	계약① 2만 (권장 3만 대비 -1만)
10	수술·입원	**입원일당-N대질병**	만원/일	3		4대성인병 → 15대·31대 성인질환으로 대상 확대	계약① 4대성인병 1만 + 5대만성질병 1만 = 2만
11	수술·입원	**입원일당-재해(상해)**	만원/일	3	5	상해입원일당은 1일차부터 지급이 표준화	계약① 2만 (권장 3만 대비 -1만). 계약② 교통상해입원일당 1만 별도
12	수술·입원	**통원일당**	만원/일			실손과 중복되어 최근 축소 추세	미가입
13	암	**CI(중대질병)진단자금**	만원			CI형은 지급요건이 엄격해 축소. GI형·일반진단비형이 주류	미가입
14	암	**중대한 수술비**	만원			CI 계열 담보. 신규 판매 축소	미가입
15	암	**암사망**	만원			암사망 단독 특약은 희소	미가입
16	암	**일반암 진단비**	만원	10,000	10,000	★진단금 일시금 → '치료 전 과정 보장'으로 이동. 치료예약 확정 시 선지급(초기 50% → 현재 70%) 구조 확산	★계약① 1,000만 (권장 1억 대비 -9,000만) — 전체 담보 중 최대 공백. 2010년 가입분으로 재진단암·고액암 없음
17	암	**암수술비**	만원	300	500	로봇수술·중입자치료 등 고액 비급여 수술을 별도 담보로 분리	계약① 100만 (권장 300만 대비 -200만)
18	암	**암입원일당**	만원/일			상급종합병원 암입원일당 가산형	계약① 5만
19	암	**암통원**	만원/회			항암치료의 통원 전환으로 통원일당 수요 증가	미가입
20	암	**고액암(특정암)**	만원	5,000	5,000	고액암 범위 확대(백혈병·뇌암·골수암·췌장암 등)	미가입 (-5,000만)
21	암	**유사암(소액암)**	만원	2,000	2,000	유사암 한도 상향(1,000만 → 2,000만 이상). 여성 갑상선암 발생 비중이 높아 실효성 큼	미가입 (-2,000만). 36세 여성 기준 발생빈도 1순위 영역
22	암	**표적항암약물허가치료비**	만원	3,000	5,000	표적·면역항암 치료비를 별도 담보화, 연간 반복지급형(1년 1회 한)	미가입 (-3,000만). 타그리소 4주 600만원 등 고액 비급여 대응 불가
23	암	**항암방사선·약물치료비**	만원		1,000	회차별 증가형(치료 반복 시 지급액 증액) 신설 — 흥국화재 5대질병 통합치료지원비 최대 1,000만	미가입
24	암	**양성자/호르몬/세기조절**	만원		3,000	중입자·양성자 치료비 별도 담보화	미가입
25	암	**암주요치료비(비급여 포함)**	만원		3,000	★★★2026 3대 핵심 트렌드 ①. 2024년 2월 삼성화재를 시작으로 전 손보사 확산. '진단 시 한 번'이 아니라 수술·항암약물치료·항암방사선치료 등 실제 치료행위를 받을 때마다 반복 지급. 표적항암제(연 6,000만~1억 2,000만원), 중입자치료(1코스 5,000만~8,000만원), 로봇수술 등 고액 비급여를 직접 보전. 치료예약 확정 시 선지급(초기 50% → 현재 70%). DB손보 최대 1억 2,000만원 / 비급여 암치료비 최대 8,000만원. 현재는 정액형만 판매(2024년 11월 비례형 중단). 시장 통용 설계 3,000만원 내외	★미가입 — 최우선 검토 대상. 계약①의 암 담보는 진단 1,000만·수술 100만·입원일당 5만이 전부로, '치료 단계'를 보전하는 담보가 하나도 없습니다. 실손(2세대)이 급여 치료비는 막아주지만 표적항암제·중입자치료 같은 비급여 고액치료는 실손 한도로 감당되지 않습니다. 가입 시 병원등급 기준(종합병원 / 암종합치료기관 / 상급종합병원 중 어디까지 인정하는지)을 반드시 확인해야 합니다
26	특정질환	**특정질병수술**	만원			16대 → N대 확대. 아래 '수술비-N대질병' 행으로 집계	계약① 16대질병수술 100만은 '수술비-N대질병' 행에 집계(중복 방지)
27	특정질환	**특정질병입원**	만원/일			성인질환 입원일당은 '입원일당-N대질병' 행으로 집계	계약① 2만은 '입원일당-N대질병' 행에 집계(중복 방지)
28	특정질환	**특정질병진단**	만원			생활질환(고혈압·당뇨·고지혈) 통합보장으로 진화 — 흥국화재 7종 세분화, 롯데손보 고당지 3·6·10	미가입
29	특정질환	**뇌혈관질환 수술비**	만원	1,000	1,000	수술비 → 주요치료비 → 순환계 통합치료비로 3단계 진화	미가입 (-1,000만)
30	특정질환	**허혈성심장질환 수술비**	만원	1,000	1,000	스텐트삽입술·관상동맥우회술 고액화(관상동맥우회술 건당 3,440만원)	미가입 (-1,000만)
31	특정질환	**혈전용해제(혈전용해치료비)**	만원			단독 담보에서 통합치료비로 흡수되는 추세	미가입
32	특정질환	**뇌·심 주요치료비 / 순환계 통합치료비**	만원		2,000	★★★2026 3대 핵심 트렌드 ②. 진단비 → 주요치료비 → 순환계 통합치료비의 3단계 진화. ① 대상 확대: 뇌혈관·허혈성심장 2대 질병 → 부정맥·심부전·판막질환 등 순환계 전반(라이나생명 62개 질병코드) ② 지급 사유 확대: MRI·PET·CT 검사, 수술, 혈전용해치료·혈전제거술, 인공호흡기·ECMO, 중환자실 치료, 항응고/항혈소판 주사, 전문재활치료까지 치료 전 과정 ③ 치료 항목별 차등 지급 + 상급종합병원 예약만으로 일부 선지급 ④ 치료기간 소득공백 보전용 생활비 지원 결합. 시장 통용 설계 2,000만원 내외	★미가입 — 최우선 검토 대상. 신OO님은 뇌·심장 담보가 진단비 단계조차 0원이라, 최신 통합치료비 구조와는 비교 자체가 성립하지 않는 상태입니다. 60대 사망원인 2위 심장질환(33,715명)·3위 뇌혈관질환(25,420명), 관상동맥우회술 건당 3,440만원·뇌기저부수술 2,035만원을 감안하면 진단비 + 통합치료비를 함께 보는 것이 현재 시장 표준입니다
33	특정질환	**5대장기이식술**	만원			조혈모세포이식 2,000~3,000만 등 이식 관련 담보 확대	미가입
34	뇌	**뇌혈관질환(100%)**	만원	3,000	3,000	진단비(기본) + 통합치료비 결합 설계가 표준. 산정특례 진단비 병행	미가입 (-3,000만)
35	뇌	**뇌혈관 산정특례**	만원			산정특례 등록 시 별도 진단비 지급 담보 신설 확산	미가입
36	뇌	**뇌졸중(77%)**	만원	3,000	3,000	뇌출혈 500~2,000만 / 뇌경색 200~1,000만. 뇌경색 감액 약관 주의	미가입 (-3,000만)
37	뇌	**뇌출혈(16%)**	만원	3,000		후유장해 50% 이상 시 추가 1,000~2,000만 지급형 확산	미가입 (-3,000만)
38	심장	**심혈관질환(100%)**	만원		3,000	허혈성 대비 보장범위가 넓은 심혈관질환 진단비로 상향 설계	미가입
39	심장	**심장 산정특례**	만원			산정특례 진단비 병행 설계	미가입
40	심장	**허혈성심장질환(85%)**	만원	3,000	3,000	60대 사망원인 2위(심장질환 33,715명). 진단비 + 통합치료비 결합	미가입 (-3,000만)
41	심장	**급성심근경색증(8%)**	만원	3,000		급심 단독보다 허혈성/심혈관 상위담보 우선 설계 권장	미가입 (-3,000만)
42	기타	**골절진단비**	만원	100		치아파절 포함형으로 확대, 깁스치료비·부목 별도 담보화	계약① 30만 + 계약② 50만 = 80만 (권장 100만 대비 -20만)
43	기타	**화상진단비**	만원			중증(심재성 2도 이상)화상 2,000만 별도 담보	계약① 50만
44	기타	**골절·화상 수술비**	만원			인공관절수술 100만, 깁스 10만 등 세분화	계약① 골절수술 60만 + 화상수술 100만
45	기타	**특정상해수술(부위별 합계)**	만원			부위별 특정상해수술은 운전자·상해보험의 표준 구성	계약② 관절30/뇌·내장100/무릎인대30/아킬레스50/안면흉터성형200/외상성척추50/인공관절100 — 부위별 개별 담보로 1사고 합산지급 아님
46	기타	**특정부위(팔·손가락) 상해후유장해**	만원			부위 한정 후유장해 담보	계약② 1,000만. 부위 한정이므로 일반 상해후유장해와 별도 집계
47	기타	**중환자실·응급실 일당**	만원/일			중환자실 15~20만/일(30~60일), 상급병실 10~15만/일 트렌드	미가입
48	기타	**기타 질환(양성뇌종양·특정전염병 등)**	만원			만성질환 통합보장 및 유병자 인수기준 완화(입원·수술 확인기간 5년 → 2년)	미가입
49	기타	**근골격계 비급여 정액담보(도수·체외충격파·증식)**	만원			5세대에서 3대 비급여(도수·비급여주사·MRI) 보장 제외 방안이 추진되면서 별도 정액담보로 분리 판매되는 추세	별도 특약 없음. 다만 신OO님의 2세대 실손은 3대 비급여가 기본 보장에 포함(자기부담 10%)되어 현재로서는 이 담보의 필요성이 낮습니다 — 2세대를 유지할 이유가 하나 더 있는 셈
50	기타	**비급여 주사제 담보**	만원			5세대 비중증 비급여 자기부담 50%·연 1,000만 한도 적용 대상. 별도 정액담보 분리 판매 확산	별도 특약 없음. 2세대 실손 기본 보장에 포함(자기부담 10%)
51	간병	**간병인사용일당(상해)**	만원/일	25	10	간병인 실제비용 10~15만원/일 → 7~10만원/일 이상 설정 권장. 간병도우미료 물가 전년비 13% 상승	미가입 (-25만)
52	간병	**간병인사용일당(질병)**	만원/일	25	10	간호·간병통합서비스 병행형 상품 확산	미가입 (-25만)
53	간병	**장기요양(1~5등급) 간병비**	만원	3,000	3,000	등급별 차등지급, 5등급·인지지원등급까지 보장 확대	미가입 (-3,000만)
54	간병	**경증치매(CDR1) 진단비**	만원	10,000	1,000	CDR1 500~1,000만 / CDR2 1,000~2,000만 / CDR3 2,000~3,000만. 신경인지기능 종합검사비 지원, 아밀로이드 베타 표적치료제 회차별 치료비 신설(하나손보)	미가입 (-1억). 일부 약관은 CDR2부터 지급하므로 CDR1 보장 여부 확인 필요
55	후유장해	**질병후유장해(80%미만)**	만원	10,000		질병 3% 이상 후유장해 비례보상형 확대	미가입 (-1억)
56	후유장해	**상해후유장해(80%미만)**	만원	10,000		상해 3% 이상 비례보상이 표준	계약① 1,000만 + 1억 5,000만 = 1억 6,000만 (권장 1억 대비 +6,000만) — 충분
57	후유장해	**고도장해**	만원			80% 이상 고도장해는 사망보험금과 동일 지급이 일반적	미가입
58	후유장해	**장해연금**	만원/년			연금형 장해보장은 생보 중심	미가입
59	실손	**질병입원의료비**	만원	5,000		5세대(2026.5.6~): 급여 연 5,000만 / 중증비급여 연 5,000만 / 비중증비급여 연 1,000만. 급여 입원 자기부담 20%, 비중증 비급여 입원 자기부담 50%. 축소된 비중증 영역은 정액 수술비·질병통합치료비로 보완하는 것이 2026년 시장 흐름	★계약① 2세대(표준화 이전기) 5,000만 — 자기부담 10%, 재가입 조건 없이 100세(2090년)까지 유지. 5세대 대비 압도적으로 유리하므로 유지가치 매우 높음
60	실손	**질병통원의료비**	만원	30		5세대는 통원 1회당 20만원 한도, 급여 통원은 건강보험 본인부담률과 연동(상급종합 이용 시 부담 증가)	계약① 외래의료비 25만 + 처방조제료 5만 = 30만
61	실손	**상해입원의료비**	만원	5,000		5세대 병의원 입원 1회당 300만원 제한 신설	계약① 상해+질병 입원의료비 5,000만 (질병입원과 동일 담보)
62	실손	**상해통원의료비**	만원	30		통원 자기부담 방식이 정액공제 → 본인부담률 연동으로 전환	계약① 외래의료비 25만 + 처방조제료 5만 = 30만
63	실손	**3대비급여(도수·주사·MRI)**	만원	350		3세대부터 특약 분리(자기부담 30%), 5세대는 비중증 비급여로 분류되어 자기부담 50%·연 1,000만 한도	별도 특약 없음. 단 2세대는 3대비급여가 기본 보장에 포함(자기부담 10%)되어 실질 보장은 오히려 우위 — '미가입'으로 보이나 실질 공백 아님
64	운전자	**벌금(대인/스쿨존/대물)**	만원	3,000	3,000	대인 3,000만(어린이보호구역 포함)·대물 500만이 최신 표준. 위험운전치상 벌금 700~1,500만 가능	계약② 2,000만 (권장 3,000만 대비 -1,000만). 2017년 약관으로 대물벌금 미탑재
65	운전자	**교통사고처리지원금**	만원	20,000	20,000	★2억~2.5억 권장. 2025년 개정으로 어린이집·유치원·초등학교 시설 내 어린이 사고가 12대 중과실에 추가	★계약② 3,000만 (권장 2억 대비 -1억 7,000만) — 운전자보험 최대 공백
66	운전자	**변호사선임비용**	만원	5,000	1,500	★2026년 개정: 심급별 최대 500만·총 1,500만 + 자기부담금 50% 신설(신규 가입분)	계약② 500만. 2017년 약관이라 자기부담금 없는 유리한 조건이나 절대 한도가 부족
67	운전자	**자동차사고부상치료비**	만원	30		부상등급 1~14급 차등, 14급(단순 타박)도 약 30만원 지급형 확산	계약① 10만(비운전자) + 계약② 20만(운전자) = 30만 — 충분
68	운전자	**중증자동차사고부상**	만원			중상해(1~3급) 고액 보장 담보 확대	계약② 1,000만
69	운전자	**교통상해입원일당**	만원/일			자동차 운전 중 상해 입원 1~180일 한정형	계약② 1만
70	운전자	**과실치사상 벌금**	만원			일반 과실치사상 벌금 담보	계약② 700만
71	운전자	**보철치료비**	만원	200		자동차사고 치아보철(영구치) 보장. 치아보험과 별개	계약② 5만 + 계약③ 200만 = 205만 — 충분. 단 계약③은 2034.10 만기 후 소멸(→ 5만만 잔존)
72	배상	**가족/일상/자녀 배상책임**	만원	10,000		1억 한도 표준, 자기부담금 2만원. 자전거·반려동물 사고 포함	계약① 1억 — 충분
73	배상	**화재벌금**	만원	2,000		실화·중과실 화재 벌금 2,000만 표준	계약② 2,000만 — 충분
74	치아	**치아보존치료(충전·인레이 등)**	만원			갱신형 치아보험은 통상 만기가 짧고 면책·감액기간(90일/50%) 존재	계약③ 40만. 2034-10-01(44세) 만기 후 보장 종료
75	치아	**기타 치과치료비**	만원			치주치료·스케일링·발치 등 소액 다빈도 보장	계약③ 주요치주질환 3만 / 영구치발치 10만 / 스케일링 1만 / 치수치료 3만 / 치아촬영 1만 (건별 지급)
76	*(추가)*	*여기부터 담보를 추가하세요*	*만원*				

사용법: ① 담보를 추가하려면 위 빈 행(회색)에 대분류·담보명·단위·권장금액을 입력하세요. ② 담보명은 '5.담보원장'의 표준담보명과 글자가 정확히 일치해야 가입금액이 합산됩니다. ③ 권장금액을 비워두면 과부족 판정에서 제외됩니다. ④ 담보 20개를 초과해 추가하려면 '3.보장분석(메인)'의 마지막 행을 복사해 아래로 붙여넣으세요.

담보원장 (가입설계서 원문 담보 → 표준담보명 매핑)

가입설계서(보장분석 PDF)의 회사 담보명을 한 줄씩 옮기고 표준담보명으로 매핑했습니다. 이 시트의 금액이 '3.보장분석(메인)'에 합산됩니다.

계약 No	상품명	구분	회사 담보명	표준담보명(→담보마스터와 일치)	가입금액	단위	비고
1	① Hi1010 (종합)	정액	기본계약	**상해(정기)사망**	1,000	만원	
1	① Hi1010 (종합)	정액	상해사망후유장해추가담보	**상해(정기)사망**	15,000	만원	
1	① Hi1010 (종합)	정액	기본계약	**상해후유장해(80%미만)**	1,000	만원	상해후유장해
1	① Hi1010 (종합)	정액	상해사망후유장해추가담보	**상해후유장해(80%미만)**	15,000	만원	상해후유장해
1	① Hi1010 (종합)	정액	암진단급여금II담보	**일반암 진단비**	1,000	만원	유사암·고액암 구분 없음
1	① Hi1010 (종합)	정액	골절(치아파절제외)진단위로금담보	**골절진단비**	30	만원	
1	① Hi1010 (종합)	정액	화상진단위로금담보	**화상진단비**	50	만원	
1	① Hi1010 (종합)	정액	16대질병수술급여금담보	**수술비-N대질병**	100	만원	신정원 매핑: 특정질병수술
1	① Hi1010 (종합)	정액	암수술급여금담보	**암수술비**	100	만원	
1	① Hi1010 (종합)	정액	골절수술위로금담보	**골절·화상 수술비**	60	만원	
1	① Hi1010 (종합)	정액	화상수술위로금담보	**골절·화상 수술비**	100	만원	
1	① Hi1010 (종합)	정액	질병입원급여금(1일이상)담보	**입원일당-질병**	2	만원/일	1일 이상
1	① Hi1010 (종합)	정액	4대성인병입원급여금담보	**입원일당-N대질병**	1	만원/일	
1	① Hi1010 (종합)	정액	5대만성질병입원급여금담보	**입원일당-N대질병**	1	만원/일	
1	① Hi1010 (종합)	정액	암입원급여금담보	**암입원일당**	5	만원/일	
1	① Hi1010 (종합)	정액	상해입원급여금(1일이상)담보	**입원일당-재해(상해)**	2	만원/일	1일 이상
1	① Hi1010 (종합)	정액	자동차사고부상위로금(비운전자)담보	**자동차사고부상치료비**	10	만원	비운전자
1	① Hi1010 (종합)	실손	상해(일반상해,전체상해) 처방조제료	**상해통원의료비**	5	만원	2세대 실손
1	① Hi1010 (종합)	실손	상해(일반상해,전체상해) 외래의료비	**상해통원의료비**	25	만원	2세대 실손
1	① Hi1010 (종합)	실손	질병(전체질병) 처방조제료	**질병통원의료비**	5	만원	2세대 실손
1	① Hi1010 (종합)	실손	질병(전체질병) 외래의료비	**질병통원의료비**	25	만원	2세대 실손
1	① Hi1010 (종합)	실손	상해+질병 입원의료비	**상해입원의료비**	5,000	만원	상해·질병 공통 1개 담보
1	① Hi1010 (종합)	실손	상해+질병 입원의료비	**질병입원의료비**	5,000	만원	상해·질병 공통 1개 담보
1	① Hi1010 (종합)	실손	가족생활배상책임	**가족/일상/자녀 배상책임**	10,000	만원	자기부담금 2만원
2	② Hi1709 (운전자)	정액	팔및손가락상해후유장해담보	**특정부위(팔·손가락) 상해후유장해**	1,000	만원	신정원 매핑: 특정교통상해사망
2	② Hi1709 (운전자)	정액	골절진단(치아파절제외)담보	**골절진단비**	50	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	관절(무릎·고관절)수술담보	**특정상해수술(부위별 합계)**	30	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	뇌·내장손상수술담보	**특정상해수술(부위별 합계)**	100	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	무릎인대파열/연골손상수술담보	**특정상해수술(부위별 합계)**	30	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	아킬레스힘줄손상수술담보	**특정상해수술(부위별 합계)**	50	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	안면부상해흉터성형수술담보	**특정상해수술(부위별 합계)**	200	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	외상성척추손상수술담보	**특정상해수술(부위별 합계)**	50	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	인공관절수술담보	**특정상해수술(부위별 합계)**	100	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	교통상해입원일당(1~180일, 자동차운전중)담보	**교통상해입원일당**	1	만원/일	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	자동차사고부상(운전자)담보	**자동차사고부상치료비**	20	만원	운전자
2	② Hi1709 (운전자)	정액	자동차사고치아보철치료비담보	**보철치료비**	5	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	정액	중증자동차사고부상(운전자)담보	**중증자동차사고부상**	1,000	만원	
2	② Hi1709 (운전자)	실손	교통사고 벌금(대인)	**벌금(대인/스쿨존/대물)**	2,000	만원	비용손해
2	② Hi1709 (운전자)	실손	화재벌금담보	**화재벌금**	2,000	만원	비용손해
2	② Hi1709 (운전자)	실손	과실치사상 벌금	**과실치사상 벌금**	700	만원	비용손해
2	② Hi1709 (운전자)	실손	교통사고처리지원금	**교통사고처리지원금**	3,000	만원	형사합의금
2	② Hi1709 (운전자)	실손	자동차사고 변호사선임비용	**변호사선임비용**	500	만원	자기부담금 없는 구약관
3	③ Hi1904 (치아)	정액	치아보존치료(갱신형)담보	**치아보존치료(충전·인레이 등)**	40	만원	
3	③ Hi1904 (치아)	정액	치아보철치료(갱신형)I담보	**보철치료비**	200	만원	영구치 보철
3	③ Hi1904 (치아)	정액	기본계약(주요치주질환치료(갱신형))	**기타 치과치료비**	3	만원	
3	③ Hi1904 (치아)	정액	영구치발치치료(갱신형)담보	**기타 치과치료비**	10	만원	
3	③ Hi1904 (치아)	정액	치석제거(스케일링)(갱신형)담보	**기타 치과치료비**	1	만원	
3	③ Hi1904 (치아)	정액	치수치료(갱신형)담보	**기타 치과치료비**	3	만원	
3	③ Hi1904 (치아)	정액	치아촬영(X-ray,파노라마)(갱신형)담보	**기타 치과치료비**	1	만원	

※ 하늘색 = 실손/비용손해 담보. ※ 담보를 추가할 때는 표준담보명을 '4.담보마스터'의 담보명과 글자까지 똑같이 입력해야 합계에 잡힙니다.

실손의료비 분석 — 세대 판정 및 전환 검토

가입 시기를 '실손보험 변천사' 기준에 대조해 세대를 판정했습니다. 전환 여부는 중립적으로 비교만 제시합니다.

1) 신OO님 실손 세대 판정

가입 계약	① 무배당하이라이프퍼펙트패키지보험(Hi1010)2종 (현대해상)
가입일	2010-12-23
판정 세대	**★ 2세대 실손 — 표준화 이전기 (2009년 10월 ~ 2013년 3월 구간)**
자기부담금	입원 10% / 통원 1~2만원 정액 공제
보장 한도	입원 5,000만원 / 통원 30만원 (외래 25만 + 처방조제 5만)
갱신 · 재가입	갱신 3년 주기 / 재가입 조건 없음 → 가입 당시 약관이 만기까지 유지
보험기간	2010-12-23 ~ 2090-12-23 (100세 만기)
3대 비급여	별도 특약 분리 없음 → 도수치료·비급여 주사·비급여 MRI가 기본 보장에 포함되며 자기부담 10% 적용

2) 실손의료보험 세대별 변천사 (전체 비교)

세대 구분	가입 시기	보장 내용(자기부담금)	가입 한도	갱신 / 재가입	주요 특징 및 변화	비고
1세대 (구실손)	~ 2009년 9월	입원: 자기부담 없음(100%) 통원: 5천원 공제	입원 3천만~1억 통원 10만~30만	갱신 3~5년 / 재가입 없음	[표준화 이전] 자기부담금이 없어 보장성 최고, 갱신 시 보험료 인상 폭 큼	
2세대 (표준화 이전기)	**2009년 10월 ~ 2013년 3월**	**입원: 10% 자기부담 통원: 1~2만원 공제**	**입원 5,000만 통원 30만**	**갱신 3년 / 재가입 없음**	**[표준화 도입] 보험사별 보장 통일, 가입 당시 조건이 만기까지 유지**	**★신OO님 해당 (2010-12-23)**
2세대 (표준화 이후기)	2013년 4월 ~ 2017년 3월	입원: 10~20% 자기부담 통원: 1~2만원 공제	입원 5,000만 통원 30만	갱신 1년 / 재가입 15년	[15년 재가입 신설] 15년 후 새 약관 기준으로 재가입 필요	
3세대 (착한실손)	2017년 4월 ~ 2021년 6월	급여 10~20% 비급여 20% 3대비급여 특약 30%	입원 5,000만 통원 30만	갱신 1년 / 재가입 15년	[기본+특약 분리] 도수치료·MRI·비급여주사 특약 분리, 무사고 할인 도입	
4세대	2021년 7월 ~ 2026년 4월	급여 20% 비급여 30%	급여/비급여 각각 입·통원 합산 연 5,000만	갱신 1년 / 재가입 5년	[보험료 차등제] 비급여 이용량에 따라 할증·할인, 재가입 주기 5년	
5세대	2026년 5월 6일 ~ 현재	급여: 입원 20%, 통원은 건보 본인부담률 연동 중증비급여 30%(연 상한 500만) 비중증비급여 50%	급여 연 5,000만 중증비급여 연 5,000만 비중증비급여 연 1,000만	갱신 1년 / 재가입 5년	[중증/비중증 분리] 중증 보장 강화, 비중증 비급여는 선택·제한 구조	

3) 2세대 유지 vs 5세대 전환 — 중립 비교

비교 항목	현재 유지 (2세대 · 표준화 이전기)	5세대로 전환할 경우	판단 시 확인할 점
보험료	상대적으로 높음. 갱신 3년 주기로 인상폭이 한 번에 크게 체감됨	4세대 대비 30~50% 저렴. 2세대 대비 체감 절감폭은 더 큼	지금 월 56,300원은 실손 외 정액담보가 포함된 금액이라 실손만 분리한 보험료 확인 필요
급여 자기부담	입원 10% (가장 낮은 수준)	입원 20%, 통원은 건강보험 본인부담률 연동	상급종합병원을 자주 이용하면 5세대 통원 부담이 커짐
비급여 자기부담	10% (3대 비급여 특약 분리 없음)	중증 비급여 30%(연 상한 500만원) / 비중증 비급여 50%	도수치료·비급여 주사·MRI 이용 빈도가 판단의 핵심
비급여 한도	입원 5,000만원 한도 내 포괄	비중증 비급여 연 1,000만원, 통원 1회 20만원, 병의원 입원 1회 300만원	비중증 한도 축소가 가장 큰 체감 변화
중증 보장	일반 한도 내 보장 (별도 상한 없음)	암·뇌혈관 등 중증 비급여는 연간 자기부담 상한 500만원으로 방어력 강화	고액 중증 치료만 놓고 보면 5세대가 유리한 구간이 있음
재가입 · 약관 변경	★재가입 조건 없음 → 2090년까지 현재 약관 유지	5년마다 재가입, 그때그때의 새 약관이 적용됨	'조건이 바뀌지 않는다'는 점이 2세대의 가장 큰 자산 — 전환하면 되돌릴 수 없음
신규 보장	임신·출산, 발달장애 급여 의료비 미보장	임신·출산 관련 의료비(산전검사·분만 등), 발달장애 급여 의료비 신규 포함	만 36세 여성으로 출산 계획이 있다면 실질 가치가 있는 항목
전환 인센티브	해당 없음	2026년 11월 시행 예정 — 1·2세대 초기 가입자 대상 선택형 할인특약 또는 계약전환 할인(전환 시 3년간 50% 할인) 중 선택	제도 시행 전이므로 확정 조건을 반드시 확인한 뒤 판단

정리	판단 기준은 '병원 이용 목적'입니다. ① 도수치료·비급여 주사 등 일상적 통증 치료를 자주 이용한다면 → 2세대 유지가 유리합니다. ② 병원을 거의 가지 않고 고액 중증 질환 대비가 목적이라면 → 보험료가 크게 낮아지는 5세대 전환도 선택지가 됩니다. ③ 다만 2세대의 '재가입 없음(약관 고정)'은 한 번 포기하면 복구할 수 없다는 점을 반드시 감안하시기 바랍니다. ④ 2026년 11월 시행 예정인 1·2세대 대상 할인 제도의 확정 내용을 본 뒤 판단하시는 것을 권합니다. ▶ 다만 실손 세대와 무관하게, 실손이 애초에 보상하지 않는 항목과 한도 초과분은 정액 수술비로만 메울 수 있습니다. 5세대 전환을 검토한다면 정액 수술비·질병통합치료비 보완이 사실상 전제 조건이 됩니다. 시트 '7.3 대핵심트렌드' ③ 참고.

2026년 3대 핵심 트렌드 — 암 주요치료비 · 순환계 주요치료비 · 정액 수술보험금

세 담보군은 서로 독립된 유행이 아니라 '진단금 중심 → 치료비 중심'이라는 하나의 흐름입니다. 신OO님 계약과의 간극을 항목별로 정리했습니다.

관통하는 흐름

과거 보험은 '병에 걸린 사실'에 돈을 줬습니다(진단금). 지금 보험은 '치료를 받는 행위'에 돈을 줍니다(치료비).
이 변화의 배경은 두 가지입니다. ① 치료 기술이 고액 비급여(표적항암제·중입자치료·로봇수술·ECMO)로 옮겨가면서 진단금 한 번으로는 치료비를 감당할 수 없게 됐습니다. ② 2026년 5월 5세대 실손이 비중증 비급여 보장을 대폭 줄이면서, 실손이 메워주던 자리를 정액 담보가 대신 메워야 하게 됐습니다.
신OO님 계약은 ①의 결과물이 하나도 없고(암·뇌·심장 치료비 담보 전무), ②에 대해서는 2세대 실손 덕분에 '실손 쪽은 유리하지만 정액 수술비 쪽은 비어 있는' 절반의 상태입니다.

트렌드	항목	시장의 현재 모습 (2026년 8월)	신OO님 계약의 현재 상태	근거 / 출처
① 암 주요치료비	무엇인가	암 진단 시 한 번 주는 진단금과 별개로, 수술 · 항암약물치료 · 항암방사선치료 등 실제 치료를 받을 때마다 반복 지급하는 담보. 2024년 2월 삼성화재를 시작으로 전 손보사로 확산됐습니다.	**해당 담보 없음. 계약①(2010년 가입)의 암 관련 담보는 진단 1,000만 · 암수술 100만 · 암입원일당 5만이 전부입니다.**	다자비 / 뱅크샐러드
	왜 필요한가	보장 대상이 고액 비급여입니다. 표적항암제 연 6,000만~1억 2,000만원, 중입자치료 1코스 5,000만~8,000만원, 타그리소 4주 600만원 · 1년 7,000만원, 엔허투 1회 투약 500만~800만원. 실손은 통원 한도가 20~30만원이라 이 금액대를 감당하지 못합니다.	**★2세대 실손이 급여 치료비는 잘 막아주지만, 비급여 항암제는 실손 한도 안에서 처리되지 않습니다. 진단금 1,000만원으로는 표적항암제 두 달치도 되지 않습니다.**	약학정보원 2023 / 뱅크샐러드
	어떻게 지급되나	① 정액형만 판매(2024년 11월부터 비례형 중단) ② 치료예약 확정 시 선지급 — 초기 50%에서 현재 70%까지 확대 ③ 연간 합산형 / 행위별 개별한도형 / 구간형(계단식)으로 나뉨 ④ DB손보 암주요치료비 최대 1억 2,000만원, 비급여 암치료비 최대 8,000만원	**미보유. 시장 통용 설계수준은 3,000만원 내외입니다.**	뱅크샐러드 / 보험신보
	확인할 점	★병원등급 기준이 상품마다 다릅니다. 종합병원까지 인정하는지, 암종합치료기관까지인지, 상급종합병원만인지에 따라 실제 지급 여부가 갈립니다. 구간형은 구간 경계에 못 미치면 지급액이 크게 줄어듭니다.	**가입 검토 시 반드시 약관에서 확인해야 할 항목입니다.**	뱅크샐러드
② 순환계 주요치료비	무엇인가	뇌·심장 보장이 '진단비 → 주요치료비 → 순환계 통합치료비'로 3단계 진화했습니다. MRI·PET·CT 검사, 수술, 혈전용해치료·혈전제거술, 인공호흡기·ECMO, 중환자실 치료, 항응고·항혈소판 주사, 전문재활치료까지 치료 전 과정을 하나로 묶어 항목별 차등 지급합니다.	**★해당 담보 없음. 그 이전 단계인 진단비조차 0원입니다. 뇌혈관질환 · 뇌졸중 · 뇌출혈 · 허혈성심장질환 · 급성심근경색 전부 미가입입니다.**	다자비 Market Trend ②
	대상이 넓어졌다	기존 2대 질병 주요치료비는 뇌혈관질환 + 허혈성심장질환에 국한됐지만, 순환계 주요치료비는 부정맥 · 심부전 · 판막질환 등 순환계 질환 전반을 포괄합니다. 라이나생명은 순환계 62개 질병코드를 담았습니다.	**신OO님은 좁은 쪽(2대 질병 진단비)조차 없어, 넓어진 시장 기준과 비교 자체가 성립하지 않습니다.**	다자비 Market Trend ②
	왜 필요한가	60대 사망원인 2위 심장질환(33,715명) · 3위 뇌혈관질환(25,420명). 2022년 수술 건당 진료비 1위 관상동맥우회술 3,440만원(연평균 +5.7%), 2위 심장수술 3,436만원, 3위 뇌기저부수술 2,035만원(+8.4%), 9위 스텐트삽입술 1,060만원. 상위 10개 중 6개가 순환계 수술입니다.	**이 금액이 발생하면 현재는 2세대 실손(자기부담 10%)으로만 대응하게 되며, 치료 기간 중 소득 공백을 메울 정액 보험금은 전혀 없습니다.**	2021 주요수술통계연보 / 국민건강보험
	최신 지급 구조	① 치료 항목별 차등 지급 ② 상급종합병원 예약만으로 일부 선지급 ③ 치료기간 생활비 지원 결합 ④ 산정특례 등록 시 별도 진단비 지급 담보 병행	**미보유. 시장 통용 설계수준은 2,000만원 내외이며, 진단비(3,000만원 수준)와 함께 구성하는 것이 현재 표준입니다.**	다자비 / 보험신보
③ 정액 수술보험금	왜 지금 중요한가	★2026년 5월 6일 시행된 5세대 실손이 비중증 비급여 보장을 대폭 축소했습니다. 자기부담률 30% → 50%, 연간 한도 5,000만원 → 1,000만원, 통원 1회 20만원 · 병의원 입원 1회 300만원 제한 신설. 도수치료 · 비급여 주사 · MRI는 아예 지금 제외 방안이 추진 중입니다.	**신OO님은 2세대라 이 축소의 직접 영향은 받지 않습니다. 다만 '실손이 애초에 보상하지 않는 항목'과 '실손 한도 초과분'은 세대와 무관하게 정액 수술비로만 메울 수 있습니다.**	보험저널 / KB의 생각
	숫자로 보면	비중증 수술비 300만원이 발생할 때 가입자 부담은 기존 90만원 → 150만원으로 늘어납니다(5세대 기준). 이 차액을 메우는 것이 정액 수술비의 역할입니다.	**2세대 유지 시 신OO님 부담은 30만원 수준이라 유리합니다. 그러나 계약①의 정액 수술 담보는 '16대질병수술 100만원' 한정형뿐이라, 16대에 들어가지 않는 수술은 정액 보험금이 0원입니다.**	보험저널
	어떤 담보로 메우나	① 1~5종 종수술비 — 급여 · 비급여를 따지지 않고 수술확인서만으로 정액 지급, 반복 청구 가능(5종 기준 500~1,000만원) ② 질병통합치료비 — 검사 · 시술 · 수술 · 중증치료를 하나로 묶은 확장형(메리츠 · KB손보 · 하나손보 등) ③ 상해 1~5종 종수술비 ④ 근골격계 비급여 · 비급여 주사제 정액담보	**①②③ 모두 미보유. 계약②의 부위별 특정상해수술 7종은 해당 부위가 아니면 지급되지 않는 한정형입니다.**	보험저널 / 시장 표준
	시장 동향	5세대 출시를 앞두고 정액형 담보 수요가 몰렸고, DB손보는 '반값 종수술비' 판매 종료를 4월까지 연기하는 등 브릿지 전략을 폈습니다. 업계는 정액 반복보장 구조가 '설명이 쉽고 설득력이 높다'고 평가합니다.	**정액 수술비는 비갱신형으로 준비하는 것이 일반적입니다. 계약①(비갱신 25년납)과 성격이 맞습니다.**	보험저널

한 줄 정리	신OO님의 보장은 '2010년의 보험'입니다. 2010년 기준으로는 나쁘지 않은 설계였고, 특히 2세대 실손은 지금도 최상급입니다. 다만 그 이후 15년간 보험이 진단금에서 치료비로 옮겨가는 동안 계약은 그대로였습니다. 암 주요치료비 · 순환계 주요치료비 · 정액 수술비 세 가지는 '더 좋은 상품으로 갈아타는' 문제가 아니라, 지금 계약에 없는 종류의 보장을 더하는 문제입니다. 기존 계약, 특히 계약①의 2세대 실손은 그대로 두는 것이 전제입니다.

담보별 최근(2026년) 담보유형 트렌드 비교

2026년 8월 기준 시장에서 판매 중인 담보 구성과 신OO님 보유 담보를 비교했습니다. 근거 출처는 하단 참고.

담보군	과거(2010~2019년 가입 시점) 구조	2026년 현재 담보유형	신OO님 계약과의 차이	출처
암	암 진단 시 일시금 지급이 전부. 유사암·고액암 구분 없음	진단금 → '치료 전 과정 보장'으로 이동. 암주요치료비(수술·항암약물·방사선 등 실제 치료행위 연동), 비급여 암치료비, 표적·면역·중입자 치료비, 치료 예약 확정 시 선지급(50%→70%), 회차별 증가형 치료지원비	**계약①은 2010년 약관으로 일반암 1,000만·암수술 100만·암입원일당 5만이 전부. 유사암·고액암·재진단암·항암치료비·주요치료비 전 항목 부재 — 최근 15년간 신설 담보군 전체가 공백**	다자비 보험AI뉴스 / 보험신보
뇌 · 심장	뇌졸중·급성심근경색 진단비 중심 (좁은 범위)	① 진단비 범위 상향(뇌졸중→뇌혈관질환, 급심→허혈성→심혈관질환) ② 주요치료비(수술·혈전용해) ③ ★순환계 통합치료비 — MRI·PET·CT 검사, 수술·혈전용해/제거술, 인공호흡기·ECMO, 항응고/항혈소판 주사, 전문재활치료까지 전 과정 포괄 ④ 산정특례 진단비 신설	**계약①②③ 모두 뇌·심장 담보가 단 하나도 없습니다. 진단비 단계조차 미가입이라 최신 통합치료비 구조와는 비교 자체가 어려운 상태**	다자비 보험AI뉴스
간병 · 치매	장기요양 담보 자체가 드물었고, 있어도 1~2등급 한정	① 장기요양 1~5등급·인지지원등급까지 확대, 등급별 차등지급 ② CDR 척도별 치매진단비 (CDR1 500~1,000만 / CDR2 1,000~2,000만 / CDR3 2,000~3,000만) ③ 간병인사용일당 7~10만원/일 이상 권장(실제 간병비 10~15만원/일) ④ 신경인지기능 종합검사비 지원, 아밀로이드 베타 표적치료제 회차별 치료비	**전 계약 미가입. 간병도우미료 소비자물가가 전년 대비 13% 상승 중이라 시간이 갈수록 공백 체감이 커지는 영역**	베이비빌리 / 보험신보
수술 · 입원	16대·4대 등 한정 질병군 수술·입원 담보	① 질병·상해 1~5종 종수술비(5종 500~1,000만) ② N대 질병 범위 확대(16대→38대·61대·105대) ③ 상급종합병원·중환자실 입원일당 가산형 ④ 로봇수술 등 고액 비급여 수술 별도 담보화	**계약① 16대질병수술 100만·입원일당 2만은 2010년 기준. 일반 질병수술비·상해수술비가 없어 '수술을 했는데 16대에 안 들어가면 못 받는' 구조. 입원일당도 현 권장 3만 대비 2만**	교보생명 뉴스룸 / 시장 표준
실손	2세대 표준화 실손 — 자기부담 10%, 3대 비급여 특약 분리 없음, 재가입 없음	5세대(2026.5.6~) — 급여/중증비급여/비중증비급여 3분할, 자기부담 20%/30%/50%, 비중증 비급여 연 1,000만 한도, 통원 1회 20만 제한, 재가입 5년	**★유일하게 신OO님이 '앞서 있는' 담보입니다. 세대가 내려갈수록 자기부담은 높아지고 한도는 줄었으므로, 2세대 유지는 그 자체로 자산입니다. 상세 비교는 시트 '6.실손분석' 참고**	KB의 생각 / 실손보험 변천사
운전자	벌금 2,000만·교통사고처리지원금 3,000만·변호사선임비용 500만이 통상 수준(2017년 기준)	① 벌금 대인 3,000만(스쿨존 포함)·대물 500만 ② 교통사고처리지원금 2억~2.5억 권장 ③ ★변호사선임비용 2026년 개정: 심급별 500만·총 1,500만 + 자기부담금 50% 신설 ④ 자동차사고부상치료비 1~14급 차등(14급 경미 부상도 약 30만) ⑤ 12대 중과실에 어린이집·유치원 시설 내 사고 추가	**계약②는 2017년 약관이라 변호사비 자기부담금 50%가 없는 유리한 조건입니다. 다만 교통사고처리지원금 3,000만은 현 합의금 시세(2억 권장) 대비 크게 부족하고, 대물벌금 담보가 없습니다**	TILNOTE 2026 운전자보험 개정 정리
생활 · 만성질환	만성질환은 인수 거절 사유이거나 담보 자체가 없었음	① 고혈압·당뇨·고지혈 통합보장(흥국화재 7종 세분화, 롯데손보 고당지 3·6·10) 및 무질환자 최대 10% 할인 ② 유병자 인수기준 완화(입원·수술 확인기간 5년→2년) ③ 헬스케어 플랫폼 연계 현물보장(연속혈당측정기·인바디·간호사 동행) ④ 무사고 시 건강지원금 환급형	**전 계약 미가입. 36세 현재는 급하지 않으나, 향후 만성질환 발생 후에는 가입이 어려워지는 담보군입니다**	보험신보 2026 상반기 상품 트렌드
사망 · 후유장해	상해사망·상해후유장해 중심(손보 종합보험 표준)	① 질병사망은 80·90세 만기 정기형으로 저렴하게 보완하는 설계가 일반화 ② 질병 3% 이상 후유장해 비례보상 확대 ③ 사망보험금 유동화(연금·요양비 전환) 제도 논의	**계약① 상해사망 1억 6,000만·상해후유장해 1억 6,000만은 권장 대비 양호하나, 질병사망 0원 / 질병후유장해 0원으로 '질병' 쪽이 통째로 비어 있습니다**	보험신보 / 시장 표준

출처

구분	자료	링크
보장분석 원자료	20260813_신O하님_보장분석.pdf (KB손해보험 경기강원GA사업단, 한국신용정보원 집적 계약정보 기반)	-
포맷 기준	보장분석24.xlsx ('김수진 가족' 시트 구분 체계)	-
실손 세대 구분	실손보험 변천사.docx	-
2026 상반기 상품 트렌드	보험신보 '2026 상반기 패러다임을 바꾼 보험상품'	https://www.insweek.co.kr/news/articleView.html?idxno=71493
순환계 통합치료비	다자비 보험AI뉴스 '순환계질환, 주요치료비 넘어 통합치료비로'	https://dazabi.com/insurance_magazine/article.php?id=25883
암보험 트렌드	다자비 보험AI뉴스 '암보험, 이제는 진단금보다 치료 전 과정 보장으로'	https://dazabi.com/insurance_magazine/article.php?id=20601
5세대 실손	KB의 생각 '5세대 실손보험 출시, 달라진 점과 전환하기 전 확인 사항'	https://kbthink.com/insurance/trend/5th-generation.html
운전자보험 2026 개정	TILNOTE '2026 운전자보험 필수 특약 추천 개정 핵심 정리'	https://tilnote.io/en/pages/69db02566b890bb9dc86f13e
간병보험 트렌드	베이비빌리 '간병보험 완전정리 2026'	https://villagebaby.kr/care/간병보험-완전정리/
5세대 실손 → 수술비 대안	보험저널 '5세대 실손 비중증 환자 부담 커진다… 수술비·질병통합치료비 대안 급부상'	https://www.insjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=30554
정액형 담보 수요	보험저널 '5세대 실손보험 출시 앞두고 … 급여·비급여 안 따지는 정액형 담보 수요 몰린다'	https://www.insjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=26340
다빈도 수술비 필요성	보험저널 '5세대 실손 나와도… 다빈도 수술비·치료비는 따로 들어야 할 판'	https://www.insjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=29067
암주요치료비 상세	뱅크샐러드 '암주요치료비 보험, 암치료비용·보장 범위 정리'	https://www.banksalad.com/articles/암주요치료비-암치료비보험-항암치료비용
순환계 주요치료비	다자비 보험AI뉴스 'Market Trend ② 심·뇌 보장, 2대 질병 넘어 순환계 주요치료비로'	https://dazabi.com/insurance_magazine/article.php?id=20298

특이사항 정리

계약·담보·기간 관점에서 반드시 짚어야 할 항목입니다.

구분	항목	내용	관련 계약	확인 시점
유지가치	**2세대 실손 (2010-12-23)**	자기부담 10%, 3대 비급여 특약 분리 없음, 재가입 조건 없이 2090-12-23(100세)까지 현재 약관 유지. 5세대(자기부담 20~50%, 비중증 연 1,000만 한도)와 비교하면 보유 계약 중 대체 불가능한 자산입니다.	계약①	상시
유지가치	**운전자보험 구약관**	2017-11-20 가입분으로 2026년 개정(변호사선임비용 심급별 500만·총 1,500만 + 자기부담금 50%) 적용을 받지 않습니다. 단 절대 한도(500만원)는 낮으므로, 해지가 아니라 '추가 보완'이 맞는 접근입니다.	계약②	상시
만기 임박	**자동차보험 만기 2026-08-19**	KB다이렉트개인용(무보험차상해 5억 / 다른 자동차 운전담보 1,000만) 보험기간이 2025-08-19 ~ 2026-08-19로, 기준일(2026-08-13) 기준 6일 뒤 만기입니다. 갱신 처리 여부를 즉시 확인해야 합니다.	별도(KB손보)	**★즉시**
만기 예정	**치아보험 2034-10-01 만기**	만 44세 만기로 3건 중 가장 먼저 종료됩니다. 만기 시 치아보존 40만·기타 치과치료비뿐 아니라 보철치료비 200만원이 함께 소멸해, 보철치료비 합계가 205만 → 5만원으로 급감합니다.	계약③	2034년
보험료	**치아보험 갱신 인상**	월 50,320원으로 전체 보험료(119,550원)의 42%를 차지하는데, 갱신형이라 갱신 시마다 인상됩니다. 보장 대비 보험료 비중이 적정한지 갱신 시점마다 점검이 필요합니다.	계약③	갱신 주기마다
보장 공백	**생존 담보 부재**	뇌혈관·뇌졸중·뇌출혈·허혈성심장질환·급성심근경색 진단비가 전부 0원, 간병·치매도 전부 0원입니다. 일반암도 1,000만원으로 권장(1억) 대비 -9,000만원입니다.	전 계약	상시
보장 공백	**질병 사망 · 질병 후유장해 0원**	상해사망 1억 6,000만·상해후유장해 1억 6,000만은 확보되어 있으나 질병 쪽은 전무합니다. 손해보험 종합보험의 전형적인 편중 구조입니다.	전 계약	상시
판정 주의	**3대 비급여실손 '미가입' 표시**	권장 350만원 대비 가입 0원으로 표시되지만, 2세대 실손은 3대 비급여가 기본 보장에 포함(자기부담 10%)되어 있습니다. 실질적인 공백이 아니므로 판정 결과를 그대로 해석하면 안 됩니다.	계약①	해석 시
집계 주의	**중복 집계 방지 처리**	① 계약①의 '16대질병수술 100만'은 신정원 매핑상 '특정질병수술'이나, 보장분석24 포맷의 '수술비-N대질병' 행에만 집계했습니다. ② 계약①의 '상해+질병 입원의료비 5,000만'은 하나의 담보이나 상해입원·질병입원 두 행에 각각 표기했습니다(원 보장분석 PDF와 동일 방식). ③ 계약②의 부위별 특정상해수술 7종은 1사고 합산지급이 아니므로 권장금액 판정에서 제외했습니다.	전 계약	해석 시
자료 한계	**신용정보원 조회 기준**	본 분석은 한국신용정보원에 집적된 계약정보(손보 2002년 12월 이후, 생보 2000년 4월 이후, 공제 2009년 10월 이후 계약 건만 조회) 기반이며 정상계약만 포함합니다. 실효·해지 건과 단체보험은 빠져 있어 실제 가입 현황과 차이가 있을 수 있습니다.	전체	해석 시

자동차보험 조회 내역 (신용정보원 · 별도 계약)

회사	상품 / 담보유형	담보명	보험기간	가입금액
KB손보	KB다이렉트개인용 / 무보험차상해	무보험차에 의한 상해(개인용,업무용,이륜차)	2025-08-19 ~ 2026-08-19	5억
KB손보	KB다이렉트개인용 / 다른자동차상해	다른 자동차 운전담보	2025-08-19 ~ 2026-08-19	1,000만